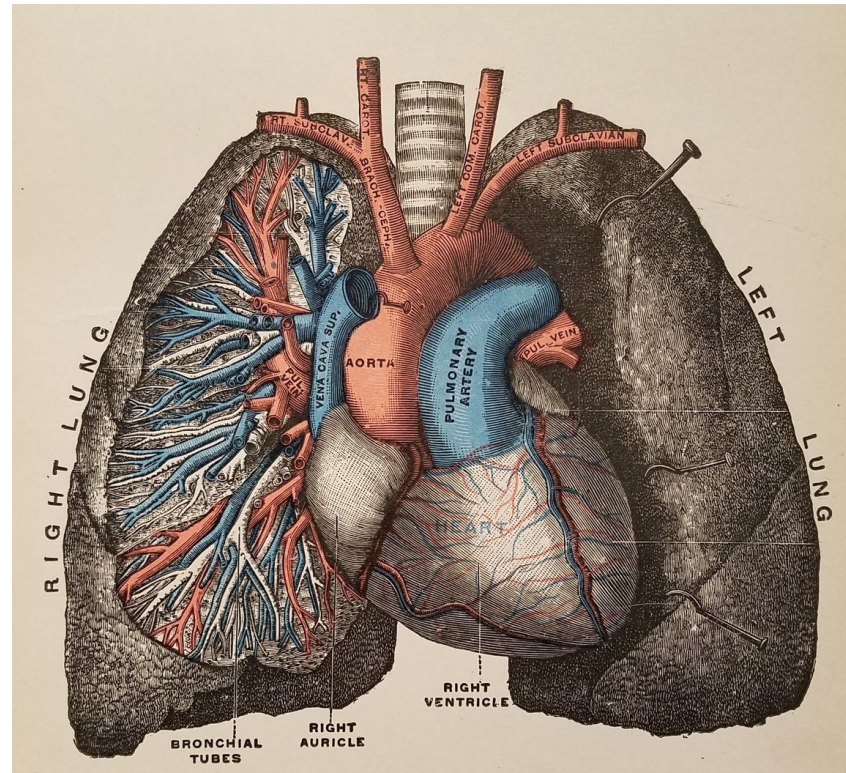
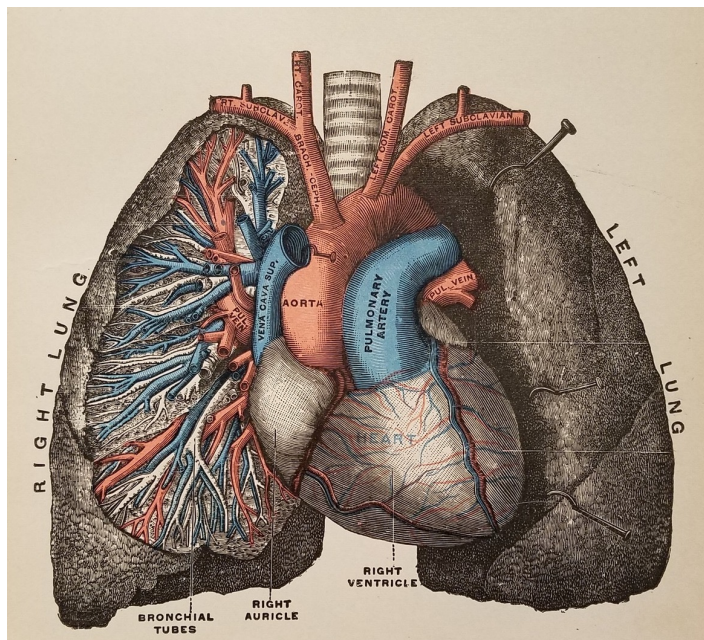


Pneumologie : Pathologies fréquentes



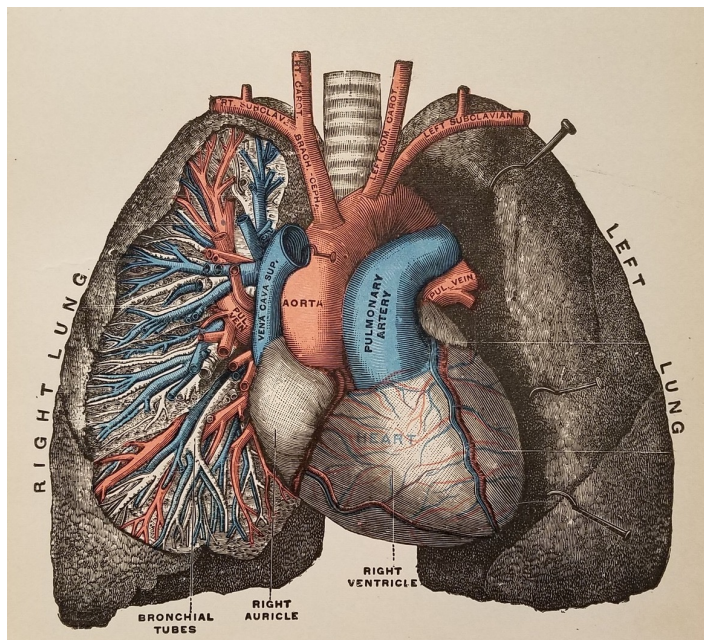


Embolie Pulmonaire (EP) :

- Cliniques**: Aspécifique, toujours avec un EP derrière la tête en cas de douleurs thoraciques ou de dyspnée aiguë.
Dyspnée (80%), **tachypnée** (70%), **tachycardie** (30%)
Douleurs thoracique (60%), en général respiro-dépendant et parfois reproductible à la palpation. **Toux** (20%) et **hémoptysie** (15%).
Parfois, présentation initiale sous forme de défaillance cardiaque avec **syncope** et **choc** (10%).
Souvent précédé d'une thrombose veineuse profonde : toujours la chercher à l'anamnèse !
En cas de complication, possibilité de développer une insuffisance cardiaque droite et un infarctus pulmonaire.
- Diagnostic**: Pour exclure une EP, dosage des **D-Dimère** (pas de valeur pronostic positive). Si probabilité très test élevée, ne pas doser les D-Dimères et aller directement à l'imagerie. Dosage de la **TnT** et du **NT-proBNP**, qui sont des signes de répercussion cardiaque et des marqueurs utilisé pour la stratification des patients. **Gazométrie** (PaO₂) pour évaluer la gravité de l'atteinte. **ECG** pour le DD d'infarctus et pour chercher des signes indirects de souffrance cardiaque droite et donc d'EP (onde P-sinusal, pattern S_IQ_{III}, inversion onde-T en V1-V4 et BBD nouveau). **Echocardiographie** (idem).
Le gold-standart pour le diagnostic formel d'EP est un **CT thoracique injecté**. Pour les patients stables, un **scintigraphie ventilation/perfusion** est également envisageable. Une recherche de **TVP asymptomatique** par **sonographie duplex** est envisageable et permet de renforcer l'hypothèse diagnostic (90% des embolies sont à points de départ des membres inférieurs).
- Traitement** : L'attitude dépend de la gravité de l'atteinte.
Si EP fulminante : O₂ ± Intubation, amine vaso-active, remplir et thrombolyser chimiquement.
Si EP sans défaillance cardiaque chez des patients stables : **anticoagulation orale** durant 3 mois ou plus (éviter récive).
Si EP avec défaillance cardiaque sans choc : Recanalisation chimique (**thrombolyse**), **endovasculaire** ou chirurgicale (**thrombectomie**).

Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) :

- Définition** : Augmentation chronique de la tension artérielle pulmonaire (**mPAP** > 20mmHg) avec augmentation des **résistances** vasculaires veineuse (PVR > 3 UI).
Cliniques: Insidieux. **Dyspnée** lentement progressive, **fatigue**, **tachycardie**, **syncope**.
Signe d'**insuffisance cardiaque droite** : Turgescence VJE, odème MI, auscultation au galop, cyanose.
Chercher des facteurs de risque pour augmenter la probabilité : **IC gauche** connue, embolie pulmonaire à répétition (**trouble de la coagulation**, **splénectomie**...), **maladie pulmonaire chronique** (BPCO, fibrose interstitielle, sarcoïdose).
- Diagnostic**: Laboratoire (**NT-proBNP**),
ECG : signe hypertrophie VD → déviation axe vers la droite, transition précoce en V1-V2, Sokolow-Lyon >1.05 mV
ECG : dilatation OD → onde-P pulmonaire
L'échocardiographie est l'examen de choix en cas de suspicion : permet d'approximer la mPAP et d'évaluer la fonction VD.
Cathétérisme cardiaque droit : Confirmation du diagnostic d'HTAP, aide au diagnostic étiologique.
- Traitement** : **Oxygénothérapie** à domicile, **médicament vasodilatateur** (antagonistes des récepteurs de l'endothéline, inhibiteur PDE-5, Analogue-Prostacycline). **Traitement causal**.

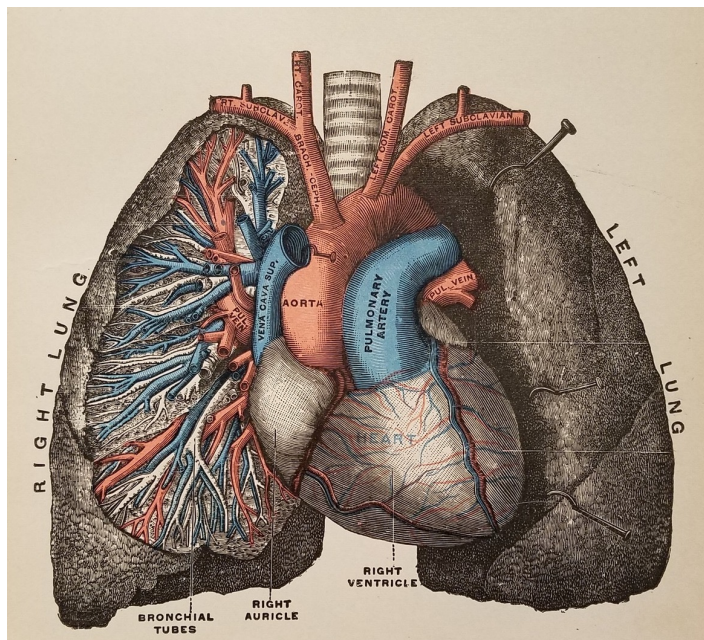


Asthme :

- **Définition :** Maladie chronique découlant d'une hyperréactivité de l'arbre bronchique à divers stimulus, provoquant une dyspnée et une toux sèche. Caractérisé par une fonction pulmonaire 'normale' entrecoupée de crise. On distingue **l'asthme allergique** (déclenché par un allergène) de **l'asthme non-allergique** (déclenché par l'effort, des irritants, des RGO, la prise d'aspirine). Formes mixtes fréquentes.
- **Cliniques:** Épisode limité dans le temps de **dyspnée** avec **stridors expiratoires** et prolongation de **l'expirium**. Souvent accompagné de toux sèches et de tachycardie. En général, crise en lien avec une exposition environnemental.
- **Diagnostic:** **Fonction pulmonaire** avec syndrome obstructif (rapport de Tieffeneau **[VEMS/CVF]** abaissé). Réversibilité sous SABA avec augmentation de la VEMS de **200mL** et de **12%**, ou péjoration après test de **provocation à la métacholine**.
- **Traitement :** Si crise grave : **SABA + Stéroïde IV + O₂/VNI/Intubation ± Sulfate de magnésium**
Traitement de fond avec un **bronchodilatateur** (LABA/SABA, LAMA, théophylline, LTRA) + **corticostéroïde inhalé** (Budenoside)

BPCO:

- **Définition :** Inflammation et obstruction des voies aériennes secondaires à une expositions chroniques à des irritants bronchiques (**tabac, pollution de l'air, déficit en α 1-AT, infection chronique**). L'inflammation et le remaniement conduisent à une augmentation des résistances, la formation d'emphysème et une inadéquation du rapport ventilation/perfusion (**effet espace-mort, $\downarrow$ Ventilation alvéolaire**) entraînant une hypoxémie et une hypercapnie chronique. Risque de décompensations « aigüe sur chronique » si des infections se surajoutent au tableau.
- **Cliniques:** **Toux grasse chronique, dyspnée** et **tachypnée**, prolongation de **l'expirium**, thorax en tonneau (hyperinflation), **cyanose** et hippocratisme digital. À la percussion, augmentation du **tympanisme** et diminution du **murmure vésiculaire** à l'auscultation. Parfois, signes d'insuffisance cardiaque droite ('**cœur pulmonaire**') avec œdème des MI, turgescences jugulaires externe et hépatomégalie. Garder les deux phénotypes possibles en tête ('**Pink Puffer**', cachéxique avec surtout de l'emphysème et une hypercapnie *versus* le '**Blue bloater**' avec surtout une bronchite chronique, une toux chronique et des oedèmes).
- **Diagnostic:** Mise en évidence d'un **syndrome obstructif** à la spirométrie (diminution de la VEMS pour une CVF normale). Le syndrome obstructif n'est **pas réversible** (ou en tous cas pas totalement) après inhalation de SABA ou de SAMA. À la **plethysmographie**, on observe une augmentation de la capacité pulmonaire totale (« **air trapping** » à cause de l'emphysème). Dû à la fibrose et au remaniement, il y a fréquemment une diminution de la **DL_{CO}** qui participe à l'hypoxémie. Labo à la recherche d'une **polycythémie secondaire** ($\uparrow$ Érythrocyte) et d'un déficit en **α 1-AT**.
ECG : signe indirect d'hypertrophie ventriculaire droite (cor pulmonale).
La **Rx thorax** et le **CT** ne **sont pas nécessaire** pour poser le diagnostic (permettent exclure DD) : hyperinflation, 'cœur pulmonaire', emphysème.
- **Traitement :** Traitement de fond avec vaccination (pneumocoque, influenza) poud diminuer le risque de sur-infection grave, Cessation des **toxiques environnementaux**, **screening** régulier contre la dépression, l'ostéoporose, les MCV et le cancer du poudmon.
TT pharmacologique : principalement sur des bronchodilatateurs $\pm$ CSI (éosinophilie > 300 cellules/ μ L, asthme)
Oxygénothérapie de Longue Durée (>15 h/jour) si hypoxémie chronique.
Les interventions possibles incluent la bullectomie et la réduction de volume pulmonaire (pour lutter contre l'emphysème).
○ En cas de décompensation : **bronchodilatateurs + stéroïde IV $\pm$ VNI/Intubation $\pm$ AB empirique** (si 2/3 critère de Anthonisen)

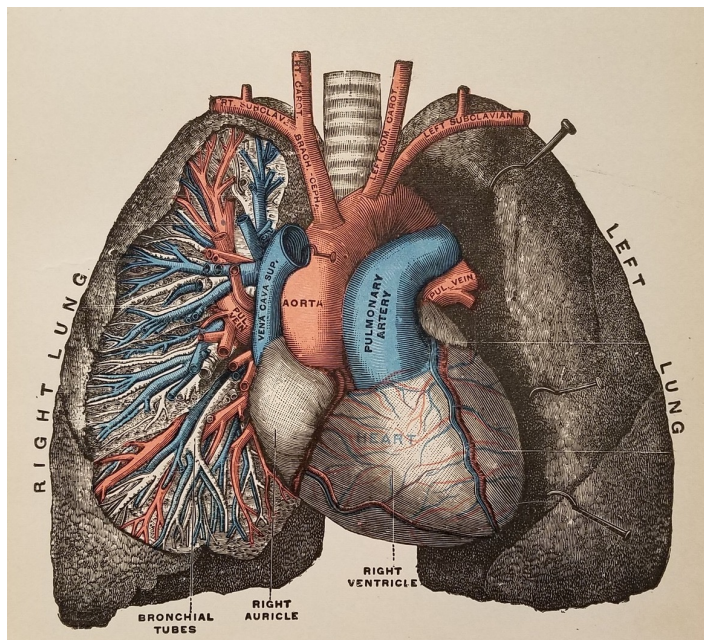


Pneumonie :

- **Définition :** On parle de pneumonie **communautaire** en cas de maladie acquise dans la communauté ou < 48h après admission à l'hôpital, et de pneumonie **nosocomiale** si le patient est tombé malade >48h après l'admission.
D'un point de vue sémiologique, on distingue également les pneumonies **typiques** (corrélât radiologique : pneumonie lobaire) des pneumonies **atypiques** (corrélât radiologique : pneumonie interstitielle). Chaque présentation clinique à une épidémiologie microbiologique différentes, permettant de choisir au mieux une antibiothérapie empirique.
- **Cliniques:**
 - **Pneumonie typique :** Début aiguë caractérisé par un EF, des frissons et une toux productive. Auscultation anormale, parfois matité à la percussion dans le lobe infecté (OAP lésionnel).
 - **Pneumonie atypique :** Début insidieux, pas/peu de fièvre, toux sèche et auscultation/percussion sans particularité.
- **Diagnostic: Signes cliniques compatible + Rx-Thorax**
Éventuellement : Culture **d'expectoration, hémoculture, test rapide urinaire, Labo** avec signes d'inflammation et éventuellement de défaillance d'organe (**sepsis** : Cr, Bilirubine, Thrombocytes + PaO2), **CT-scanner, ponction** de liquide pleurale en cas d'épanchement, bronchoscopie avec LBA à visée diagnostic, PCR/Culture pour la Tb...
- **Traitement :** Traitement empirique ou sur la base des tests rapides. En fonction de l'état clinique et des germes suspectés. Évaluer et re-évaluer le besoin d'une hospitalisation (âge, FR, PAM, confusion) et les effets de l'AB empirique (à 48h).
- Pneumonie communautaire non-hospitalisé : **Amoxicilline PO** ou **co-amoxicilline PO**
Pneumonie communautaire hospitalisé sans FR pour Pseudomonas : **Co-amoxicilline** ou **Ceftriaxone IV**
Pneumonie communautaire hospitalisé avec FR Pseudomonas : **Céfépime (C4G)** ou **Pip-tazo IV**
Si sévère (VNI, sepsis, soins continus ou intensifs) : Ajouter **Azithromycine IV** (même sans suspicion germe atypique)
Si compliqué d'un choc : Ajouter **Amikacine IV**

Pneumothorax:

- **Définition :** Accumulation d'air dans l'espace pleurale, avec rupture de la plèvre viscérale uniquement (pneumothorax **fermé**) ou des plèvres viscérale et pariétale (pneumothorax **ouvert**). On distingue également les pneumothorax en fonction de leur étiologie :
 - **Spontané :** **idiopathique** (85%) ou **secondaire** à une maladie pulmonaire (15%)
 - **Traumatique** (en général pneumothorax ouvert)
 - **Iatrogène** (après une ponction pleurale, une pose de cathéter sub-clavière)
- **Cliniques:** Apparition brutale de **dyspnée** avec **tachypnée** et **dyspnée** avec **douleurs thoracique**. Chercher des facteurs de risque : Pneumothorax secondaire → **BPCO avec emphysème** > Asthme, pneumopathie interstitielle, cancer du poumon, pneumonie...
Pneumothorax idiopathique → Jeune homme **fumeur**, mince et grand (**Marfanoïde**)
- **Diagnostic: Percussion** (thorax hyper-sonore), **auscultation** (diminution/absence de murmure vésiculaire), mouvement respiratoire **asymétrique**. Confirmation par **US** (signe du code-barre, perte du 'signe de la plage'), **Rx-Thorax**
- **Traitement :**
Pneumothorax engendrant peu de symptôme => résolution **spontanée** ou ventiller avec air sans N2 ('**dénitrogénisé**'),
Pneumothorax compressif ou engendrant dyspné(+) => Pose d'un **drain thoracique**



Sarcoïdose aigüe :

- **Définition :** La sarcoïdose est une maladie multisystémique auto-immune d'origine indéterminée, caractérisé par une inflammation granulomateuse non caséeuse touchant principalement les ganglions et les poumons, mais pouvant impliquer tous les organes. Présentation **aigüe** (en général spontanément résolutive après quelques années, 10% des cas) ou **chronique** (90%). La sarcoïdose aigüe peut se présenter sous la forme d'un syndrome de **Löfgren** (fréquent) ou de **Heerfordt** (rarement).
- **Syndrome de Löfgren**
 - **Clinique:** se caractérise par la présence d'un EF avec la triade suivante: **Érythème noueux** + **adénopathie bi-hilaire** + **arthrite migrante** (cheville).
Diagnostique: En général, sur la base de la clinique (arthrite , érythème noueux) et d'une Rx thorax.
 - **Traitement :** Gestion des douleurs articulaires avec des **AINS** ± de la **colchicine**.
En général, excellent pronostic avec 90% de rémission à 2 ans
 - **Syndrome de Heerfordt :**
Caractérisé par la triade suivante : **Parotidite** + **Paralysie faciale périphérique** + **Uvéite**

Sarcoïdose chronique:

- **Cliniques:**
Développement **insidieux** d'une fatigue avec perte de poids et état sub-fébrile, d'une **dyspnée** accompagné d'une **toux sèche** et de douleurs thoracique (symptôme pulmonaire dans 95% des cas). Parfois, développement de symptômes touchant d'autres organes :
Cutanée (25%) : lupus pernio, plaques ou nodules violacées, érythème noueux
Oculaire (20%) : Uvéite, rétinite, conjonctivite, calcification
Hépatique (10%) : Élévation des transaminases
Neuro-sarcoïdose (10%) : Méningite lymphocytaire, paralysie faciale, insuffisance hypophysaire
- **Diagnostique:** Clinique + **biopsie de ganglion touchés** (en général médiastinaux) + exclusion d'autres maladies granulomateuse.
Laboratoire : élévation du **calcium** (sécrétion de PTH-rp), élévation du **s.IL-2.R** et de **l'ACE**
LBA : Augmentation du **rapport CD4⁺/CD8⁺** (LTh1 nécessaire à la constitution de granulome)
Fonction pulmonaire : syndrome obstructif ou restrictif, diminution de la **DL.CO**
- **Traitement** : **CS oraux** en cas de décompensation respiratoire, **tt de fond immunosuppresseur**.